

Fistule recto-urétrale (chez l'homme)

WARWIKI

Information pour le patient · Une communication anormale entre le rectum et l'urètre

Une fistule recto-urétrale est une communication anormale (un petit tunnel) entre le **rectum** (intestin terminal) et l'**urètre** (tube urinaire). Elle peut laisser passer de l'urine dans le rectum, et des gaz ou des selles dans les urines, entraînant des infections répétées. C'est une situation difficile à vivre, mais elle peut être réparée — généralement par une approche planifiée en plusieurs temps.

À propos de cette affection

Les symptômes incluent souvent **des gaz ou des selles dans les urines** (bulles lors de la miction, urine trouble ou malodorante), **des fuites d'urine par le rectum**, des infections urinaires récidivantes et une gêne pelvienne. C'est un problème mécanique qui a une solution mécanique — pas le reflet de quelque chose que vous auriez fait.

Causes

La plupart des fistules recto-urétrales sont une **complication du traitement du cancer de la prostate** — chirurgie (prostatectomie), **radiothérapie** ou ablation (cryothérapie ou HIFU) — ou surviennent après une chirurgie rectale. Plus rarement, elles résultent d'un traumatisme, d'une infection ou d'une maladie inflammatoire de l'intestin. Les fistules consécutives à la **radiothérapie** sont plus complexes à guérir.

COMPRENDRE LES TERMES

Fistule

Un tunnel anormal reliant deux organes.

Recto-urétrale

Entre le rectum et l'urètre.

Pneumaturie

Gaz ou bulles dans les urines.

Fécalurie

Matières fécales dans les urines.

Dérivation

Déviations temporaires des urines et/ou des selles pour favoriser la cicatrisation.

Colostomie

Ouverture temporaire pour les selles, souvent réversible ultérieurement.

Lambeau de gracilis

Lambeau du muscle de la cuisse souvent utilisé pour renforcer la réparation.

POURQUOI POURRAIS-JE AVOIR BESOIN D'UNE STOMIE OU D'UNE SONDE EN PREMIER ? Dériver les urines (sonde ou tube) et parfois les selles (colostomie temporaire) soulage la zone, contrôle l'infection et laisse les tissus inflammés se stabiliser — ce qui donne à la réparation ultérieure les meilleures chances de cicatrisation. Ces **dérivations sont temporaires** et supprimées après guérison.

Comment on le diagnostique

- Examen de la vessie et de l'urètre (**cystoscopie**) et du rectum
- **Tests au colorant** et imagerie pour localiser et mesurer la fistule
- Revue de vos antécédents (traitement prostatique, radiothérapie) et de la qualité des tissus

Comment on le traite

- 1 **Stabiliser et dériver** — une sonde (et parfois une colostomie temporaire) pour contrôler les symptômes et laisser les tissus récupérer.
- 2 **Réparation chirurgicale** — le plus souvent par voie périnéale (entre le scrotum et l'anus), en refermant la communication en plusieurs plans.
- 3 **Lambeau de tissu** — un muscle sain (souvent le **gracilis** de la cuisse) est interposé entre les sutures, surtout après radiothérapie.
- 4 **Rétablissement** — les stomies temporaires sont fermées ultérieurement, une fois la cicatrisation confirmée.

Bon à savoir

- Le moment compte — les chirurgiens attendent souvent que l'inflammation se calme avant d'opérer.
- Les petites fistules sans antécédent de radiothérapie peuvent parfois se fermer avec une sonde seule.
- Une bonne nutrition et l'arrêt du tabac favorisent la cicatrisation.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- **Fièvre, frissons ou malaise important** (infection grave possible)
- Douleur pelvienne ou rectale intense
- **Impossibilité d'uriner** ou saignement abondant

TROIS CHOSES À RETENIR

1. Une fistule recto-urétrale relie le rectum et l'urètre — causant gaz/selles dans les urines et infections — le plus souvent après un traitement du cancer de la prostate.
2. La prise en charge est généralement en plusieurs temps : dériver et stabiliser d'abord, puis réparer (souvent avec un lambeau, surtout après radiothérapie), puis fermer les stomies temporaires.
3. Elle est réparable. Consultez en urgence en cas de fièvre, de douleur intense ou d'impossibilité d'uriner.